Corrigé de SSR PF GU et genre

Examen blanc INFAS Abengourou Septembre 2026 Licence 3 SFM Version A

Corrigé avec questions, propositions, réponses, explications et sources. Les numéros de page des cours renvoient aux pages du fichier PDF, couverture comprise. Les références en ligne sont détaillées à la fin du document.

Questions à choix double

Pour chaque affirmation : A = Vrai ; B = Faux. Réponse juste : +1 point ; réponse fausse : −1 point ; absence de réponse : 0 point.

Question 1. Une femme dont les cycles varient entre 25 et 30 jours peut appliquer directement la méthode des jours fixes, car cette méthode convient à tout cycle compris entre 25 et 35 jours.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La méthode des jours fixes convient à des cycles habituellement compris entre 26 et 32 jours. Des cycles de 25 jours ne répondent pas à ce critère.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode des jours fixes, critères d’utilisation », p. PDF 33 et 35.

Question 2. Pour calculer la période féconde selon la méthode d'Ogino-Knauss, on soustrait 18 à la durée du cycle le plus court et 11 à la durée du cycle le plus long.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Premier jour estimé fertile = cycle le plus court − 18. Dernier jour estimé fertile = cycle le plus long − 11. On utilise les cycles récemment observés.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode du calendrier ou Ogino-Knauss », p. PDF 30.

Question 3. Une utilisatrice de la MAMA reste protégée contre la grossesse jusqu'au retour des règles, même si son enfant reçoit des compléments alimentaires à partir du quatrième mois.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La MAMA nécessite simultanément : enfant de moins de six mois, absence de retour des règles et allaitement exclusif ou quasi exclusif avec tétées fréquentes. Des compléments réguliers peuvent faire perdre ces conditions.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « MAMA, conditions d’efficacité », p. PDF 38–39.

Question 4. Chez une femme présentant une hypertension artérielle à 170/105 mm Hg, un contraceptif hormonal combiné peut être proposé sans précaution particulière.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Une pression artérielle de 170/105 mmHg relève d’une hypertension sévère. Les contraceptifs hormonaux combinés sont classés en catégorie 4 : risque inacceptable.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Critères médicaux d’éligibilité des CHC », p. PDF 60.

Question 5. Une femme qui allaite exclusivement peut ovuler avant le retour de ses premières règles après l'accouchement.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : La première ovulation peut précéder les premières règles. L’allaitement exclusif réduit ce risque, sans l’annuler ; la MAMA exige aussi l’aménorrhée et un enfant de moins de six mois.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « MAMA et retour à la fécondité après l’accouchement », p. PDF 39 et 131.

Question 6. Le counseling spécifique à la méthode consiste à donner à la cliente les informations pratiques nécessaires à l'utilisation correcte de la méthode choisie.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Ce counseling explique le mode d’emploi, les effets attendus, les précautions, les signes d’alerte et le suivi de la méthode retenue par la cliente.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Counseling spécifique à la méthode », p. PDF 23.

Question 7. Selon la conduite enseignée pour la pilule combinée dans ce cours, un vomissement dans les deux heures suivant la prise ne nécessite aucune mesure, car le comprimé est déjà totalement absorbé.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Le cours conseille un comprimé de remplacement après un vomissement dans les deux heures. La conduite dépend aussi de la formulation et de sa notice ; on ne peut pas affirmer une absorption totale systématique.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions aux utilisatrices de COC », p. PDF 55.

Question 8. Dans la méthode des jours fixes, les rapports non protégés doivent être évités du huitième au dix-neuvième jour du cycle.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : La fenêtre de précaution s’étend du 8e au 19e jour inclus. Il faut s’abstenir de rapports ou utiliser une protection pendant ces jours.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode des jours fixes », p. PDF 33–35.

Question 9. Le stock disponible et utilisable correspond à l'inventaire physique total, sans soustraire les produits périmés ou avariés.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Le stock disponible et utilisable ne comprend que les produits aptes à être distribués : les produits périmés, détériorés ou non conformes en sont exclus.

Source : Ministère de la Santé de Côte d’Ivoire, Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, procédures d’inventaire et de détermination du SDU.

Question 10. Dans le calcul de routine au niveau d’un établissement sanitaire de premier contact, la consommation moyenne mensuelle peut être calculée à partir de trois mois typiques de consommation.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Au niveau ESPC, le manuel national prévoit la consommation de trois mois divisée par trois. Les mois atypiques ou les ruptures doivent être pris en compte selon le protocole ; d’autres niveaux utilisent une autre période.

Source : Ministère de la Santé de Côte d’Ivoire, Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, p. PDF 118, Calculer la CMM.

Question 11. Dans une version revue continue du système Max-Min, une commande est passée lorsqu'un produit atteint ou franchit le niveau minimum.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : En revue continue, le niveau est vérifié lors des sorties. Une commande est déclenchée lorsque le stock atteint ou passe sous le minimum, pour le ramener au maximum.

Source : USAID DELIVER, The Logistics Handbook, 2011, chapitre 4, p. PDF 73, Continuous review max-min system.

Étude de cas 1

Mme A., 29 ans, consulte pour espacer les naissances. Ses six derniers cycles ont une durée comprise entre 25 et 30 jours. Elle souhaite une méthode naturelle, mais son conjoint voyage souvent. Elle présente actuellement une infection vaginale avec des sécrétions abondantes. Elle demande aussi si la méthode la protège contre le VIH. Les questions 12 à 15 se rapportent à cette situation.

Question 12. Selon la méthode d'Ogino-Knauss, sa période féconde estimée se situe du 7e au 19e jour du cycle.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : 25 − 18 = 7 et 30 − 11 = 19. La période féconde estimée va donc du 7e au 19e jour inclus. Il s’agit d’une estimation contraceptive, pas d’une certitude biologique.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Ogino-Knauss, exemple de cycles de 25 à 30 jours », p. PDF 30.

Question 13. L'interprétation difficile de la glaire cervicale justifie une méthode d'appoint ou un autre choix contraceptif.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Une infection et des sécrétions inhabituelles peuvent masquer les signes de glaire fertile. Il faut évaluer et traiter l’infection, et proposer une protection ou une autre méthode.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Glaire cervicale et situations perturbant l’observation », p. PDF 31–32 et 35.

Question 14. L'absence de coopération du partenaire ne compromet pas l'utilisation correcte d'une méthode d'auto-observation nécessitant l'abstinence pendant la période fertile.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : La coopération du partenaire est importante pour éviter les rapports non protégés pendant la période fertile. Son absence peut réduire l’efficacité pratique de la méthode.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthodes d’auto-observation, conditions et limites », p. PDF 29–30.

Question 15. La méthode d'Ogino-Knauss protège la cliente contre le VIH si le calcul de la période fertile est correctement réalisé.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Le calcul du calendrier ne protège contre aucune IST. Les préservatifs, utilisés correctement et régulièrement, contribuent à prévenir la transmission sexuelle du VIH.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthodes d’auto-observation et méthodes barrières », p. PDF 29–30 et 41–46.

Étude de cas 2

Mme B. prend une pilule combinée. Elle a oublié deux comprimés actifs consécutifs et a eu un rapport non protégé. Elle présente par ailleurs un épisode de vomissement moins de deux heures après une prise et signale des saignements depuis le début de la méthode. Les questions 16 à 19 se rapportent à cette situation.

Question 16. Après l'oubli de deux comprimés ou plus, il convient de reprendre deux comprimés par jour jusqu'au rattrapage et d'utiliser une méthode d'appoint pendant sept jours.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Après au moins deux comprimés actifs consécutifs oubliés, prendre le dernier oublié, écarter les précédents et continuer normalement, avec préservatifs pendant sept jours. Évaluer une contraception d’urgence, notamment si l’oubli touche la première semaine avec rapport récent.

Source : CDC, U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2024, Combined Hormonal Contraceptives, conduite après oubli de pilule.

Question 17. Les saignements au cours des trois premiers mois imposent systématiquement l'arrêt immédiat de la pilule combinée.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : B — Faux

Explication : Des saignements peu abondants sont possibles au début d’une contraception combinée. Ils n’imposent pas l’arrêt systématique ; rechercher une mauvaise observance ou une autre cause si nécessaire, surtout si les saignements sont importants ou persistants.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Conseils de suivi et effets secondaires des COC », p. PDF 55 et 63–64.

Question 18. Selon les consignes du cours pour la pilule combinée, en cas de vomissement dans les deux heures suivant la prise, la cliente doit prendre un comprimé de remplacement puis poursuivre sa plaquette.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : C’est la consigne figurant dans le cours pour cette situation. Le remplacement ne signifie pas de prendre deux comprimés tous les jours. Si les vomissements persistent, réévaluer la protection et suivre les recommandations de la formulation utilisée.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions pour les clientes sous COC », p. PDF 55.

Question 19. Si la cliente n'a pas de règles pendant deux mois ou plus, elle doit revenir au centre pour vérifier l'absence d'une grossesse.

A. Vrai. B. Faux.

Réponse : A — Vrai

Explication : Le cours recommande de revenir en cas d’absence de saignement pendant deux mois. Une grossesse doit être recherchée selon les oublis et les rapports ; une aménorrhée sous contraception peut aussi être bénigne.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions pour les clientes sous COC », p. PDF 55.

Questions à choix multiple

Choisir la ou les réponses exactes. Lire toutes les propositions avant de répondre.

Question 20. Une cliente demande la définition opérationnelle de la planification familiale. Quelle réponse est la plus exacte ?

A. La PF consiste uniquement à traiter l'infertilité.

B. La PF regroupe les moyens permettant d'éviter les grossesses non désirées, d'espacer les naissances et de déterminer la taille souhaitée de la famille.

C. La PF vise uniquement à réduire la mortalité infantile.

D. La PF consiste à imposer une méthode contraceptive à tous les couples.

Réponse : B

Explication : La PF permet un choix volontaire concernant les grossesses, leur espacement et la taille souhaitée de la famille. Elle comporte aussi la prévention et la prise en charge de l’infertilité.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Concept de la planification familiale, définition et composantes », p. PDF 12.

Question 21. Une équipe de district veut réduire les grossesses trop rapprochées. Quelle intervention relève directement de la PF ?

A. Limiter l'accès des adolescentes aux services.

B. Proposer une information et un choix volontaire de méthodes contraceptives.

C. Réserver les services aux femmes mariées.

D. Supprimer le counseling pour accélérer les consultations.

Réponse : B

Explication : L’information, le conseil et l’accès volontaire à des méthodes adaptées permettent d’éviter les grossesses trop rapprochées. L’accès ne doit pas être réservé aux femmes mariées.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Planification familiale et principes du counseling », p. PDF 12 et 22.

Question 22. Dans une communauté, les rumeurs et le manque d'information réduisent l'utilisation de la PF. Cet obstacle est principalement :

A. Économique.

B. Institutionnel.

C. Socioculturel.

D. Biologique.

Réponse : C — Socioculturel

Explication : Les rumeurs, croyances et informations erronées constituent des obstacles socioculturels à l’utilisation des méthodes.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Obstacles à la planification familiale », p. PDF 12–13.

Question 23. Une cliente souhaite retrouver rapidement sa fécondité à l'arrêt de la méthode. Quelle qualité contraceptive correspond à cette attente ?

A. La réversibilité.

B. La migration.

C. La mortalité.

D. La périodicité des rapports.

Réponse : A — Réversibilité

Explication : La réversibilité décrit le retour à la fécondité après l'arrêt de la méthode. Sa rapidité varie selon la méthode, ce qui doit être expliqué au moment du choix.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Qualités d'une méthode contraceptive », p. PDF 15.

Question 24. Quelle méthode contraceptive contribue également à réduire le risque de transmission sexuelle du VIH ?

A. Le DIU au cuivre.

B. La pilule progestative.

C. Le préservatif masculin ou féminin.

D. La méthode des jours fixes.

Réponse : C

Explication : Les préservatifs masculins ou féminins contribuent à réduire le risque de VIH lorsqu'ils sont utilisés correctement et régulièrement. Les autres méthodes citées n'assurent pas cette protection.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthodes de barrière », p. PDF 41–46.

Question 25. Dans le cadre d'une conception naturelle par rapports vaginaux, quelle combinaison décrit les conditions favorables à la survenue d'une grossesse ?

A. Ovulation, trompes perméables, glaire favorable, spermatozoïdes suffisants et endomètre réceptif.

B. Menstruation, fièvre, glaire épaisse et endomètre non réceptif.

C. Absence d'ovulation et obstruction des trompes.

D. Glaire hostile et absence de spermatozoïdes.

Réponse : A

Explication : Cette combinaison réunit les conditions favorables à la fécondation naturelle et à l'implantation : ovulation, spermatozoïdes fonctionnels, perméabilité tubaire, glaire propice et endomètre réceptif.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Interférence avec les conditions de la grossesse », p. PDF 15.

Question 26. Une cliente ayant des cycles de 26 à 30 jours demande le calcul de sa période féconde selon Ogino-Knauss. Quelle proposition est correcte ?

A. Du 5e au 20e jour.

B. Du 8e au 19e jour.

C. Du 9e au 20e jour.

D. Du 11e au 18e jour, quel que soit le cycle.

Réponse : B — Du 8e au 19e jour

Explication : Cycle le plus court : 26 − 18 = 8. Cycle le plus long : 30 − 11 = 19. La fenêtre calculée est donc du 8e au 19e jour inclus.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode du calendrier ou Ogino-Knauss », p. PDF 30.

Question 27. Une femme utilise la méthode de la glaire cervicale. Elle observe une glaire abondante, transparente et filante, comparable à du blanc d'œuf cru. Cette observation indique surtout :

A. Une période d'infécondité certaine.

B. Une période proche de l'ovulation et de fertilité élevée.

C. Une infection toujours certaine.

D. La fin définitive de la période fertile.

Réponse : B

Explication : Sous l’effet des œstrogènes, la glaire devient abondante, claire, glissante et filante près de l’ovulation. Cet aspect signale une période fertile.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode de la glaire cervicale », p. PDF 31–32.

Question 28. Une cliente sous méthode de la température basale présente une infection aiguë. Quelle conséquence pratique faut-il envisager ?

A. L'infection peut modifier la température et perturber l'interprétation.

B. L'infection améliore la précision de la méthode.

C. La température basale devient inutile uniquement après la ménopause.

D. Il faut augmenter la température mesurée de 2 °C.

Réponse : A

Explication : Une infection, en particulier fébrile, peut modifier la température indépendamment de l’ovulation. La courbe est alors plus difficile à interpréter.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode de la température basale », p. PDF 30–31.

Question 29. Une femme a des cycles de 28 jours et souhaite utiliser la méthode des jours fixes. Quelle consigne est appropriée ?

A. Avoir des rapports non protégés du 8e au 19e jour.

B. Éviter les rapports non protégés du 8e au 19e jour.

C. Éviter uniquement le premier jour des règles.

D. Utiliser la méthode même si ses cycles descendent en dessous de 26 jours.

Réponse : B

Explication : Avec des cycles de 28 jours, la femme peut utiliser la méthode des jours fixes si les autres conditions sont réunies : éviter les rapports non protégés du 8e au 19e jour inclus.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthode des jours fixes », p. PDF 33–35.

Question 30. Une cliente demande la principale limite commune aux méthodes d'auto-observation. Quelle réponse est la plus pertinente ?

A. Elles protègent contre les IST.

B. Elles exigent l'observation correcte des signes de fertilité et la coopération du couple.

C. Elles sont irréversibles.

D. Elles provoquent toujours une aménorrhée.

Réponse : B

Explication : Ces méthodes reposent sur une observation et une interprétation fiables, ainsi que sur l’adaptation des rapports pendant les jours fertiles. Elles ne protègent pas des IST.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Méthodes d’auto-observation, conditions et limites », p. PDF 29–32.

Question 31. Une femme souhaite utiliser la MAMA. Lequel des éléments suivants est indispensable à son efficacité ?

A. Enfant âgé de moins de six mois, allaitement exclusif ou quasi exclusif, et absence de retour des règles.

B. Enfant âgé de plus d'un an et alimentation complémentaire dominante.

C. Retour des règles depuis deux mois.

D. Utilisation simultanée obligatoire d'un contraceptif combiné.

Réponse : A

Explication : Les trois critères sont simultanément nécessaires : bébé de moins de six mois, allaitement exclusif ou quasi exclusif suffisamment fréquent, et aménorrhée. Si un critère disparaît, prévoir une autre protection.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « MAMA, conditions d’efficacité », p. PDF 38–39.

Étude de cas 3

Mme C. a accouché il y a 24 jours. Elle n’a pas eu de retour de règles et allaite exclusivement son nouveau-né, avec des tétées fréquentes, sans intervalle supérieur à quatre heures le jour ni six heures la nuit. Elle a eu un rapport sans préservatif il y a 72 heures. Elle souhaite une contraception compatible avec l’allaitement. Au centre, le stock disponible et utilisable de pilules progestatives est de 460 cycles. Les consommations des trois derniers mois typiques, sans rupture de stock, sont de 105, 100 et 110 cycles. Les questions 32 à 35 se rapportent à cette situation.

Question 32. Dans ce cas où les trois critères de la MAMA sont réunis, quelle conduite contraceptive est appropriée ?

A. Attendre le retour des règles sans expliquer les conditions de protection.

B. Une contraception d’urgence n’est pas nécessaire pour ce rapport ; vérifier le maintien des critères de la MAMA et discuter une méthode régulière compatible avec l’allaitement.

C. Prescrire systématiquement une contraception combinée sans évaluation.

D. Conseiller uniquement le calendrier alors que les cycles n’ont pas repris.

Réponse : B

Explication : Dans ce cas, les trois critères de la MAMA sont réunis : le rapport ne justifie pas une contraception d’urgence. Vérifier ces critères et anticiper une autre méthode dès qu’un critère cesse d’être rempli.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « MAMA », p. PDF 38–39. NICE, Contraception emergency, Management, contraception après l’accouchement et exception MAMA.

Question 33. Concernant le post-partum, quel énoncé est le plus juste ?

A. Une grossesse est impossible avant le retour des premières règles.

B. L'ovulation peut précéder le retour des règles ; une contraception doit donc être discutée.

C. L'allaitement protège toujours pendant douze mois.

D. Toutes les méthodes sont obligatoirement contre-indiquées pendant l'allaitement.

Réponse : B

Explication : Une ovulation peut avoir lieu avant le retour des règles. Le conseil contraceptif doit donc être proposé avant le retour de couches, même si la MAMA peut fournir une protection temporaire.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Post-partum, retour à la fécondité », p. PDF 131.

Question 34. Quelle est la consommation moyenne mensuelle à partir des trois consommations indiquées ?

A. 95 cycles.

B. 100 cycles.

C. 105 cycles.

D. 315 cycles.

Réponse : C — 105 cycles par mois

Explication : CMM = (105 + 100 + 110) ÷ 3 = 315 ÷ 3 = 105 cycles par mois. Les trois mois sont considérés comme représentatifs et sans rupture de stock.

Source : Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, p. PDF 118, Calculer la CMM.

Question 35. Quel est le nombre de mois de stock disponible, en utilisant la formule MSD = SDU/CMM ?

A. 2 mois.

B. 3 mois.

C. Environ 4,4 mois.

D. 5,6 mois.

Réponse : C — Environ 4,4 mois

Explication : MSD = SDU ÷ CMM = 460 ÷ 105 = 4,38 mois, soit 4,4 mois après arrondi à une décimale. Les unités de stock et de consommation doivent être identiques.

Source : Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, p. PDF 119, Déterminer le nombre de mois de stock disponible.

Question 36. Chez une cliente médicalement éligible à un contraceptif hormonal combiné, quelle condition permet un démarrage en dehors des règles ?

A. Le prestataire est raisonnablement certain qu'elle n'est pas enceinte.

B. Elle présente une douleur pelvienne aiguë.

C. Elle a une hypertension sévère non contrôlée.

D. Elle ne souhaite pas utiliser de méthode d'appoint.

Réponse : A

Explication : L'absence de grossesse doit être raisonnablement certaine et l'éligibilité vérifiée. En dehors des cinq premiers jours des règles, une protection complémentaire est généralement nécessaire pendant sept jours.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Moment d'administration des CHC », p. PDF 53. CDC, Combined Hormonal Contraceptives, 2024, Initiation.

Question 37. Une cliente prend une pilule combinée en plaquette de 28 comprimés. Que doit-elle faire lorsque la plaquette est terminée ?

A. Attendre deux semaines avant de recommencer.

B. Commencer immédiatement une nouvelle plaquette.

C. Arrêter définitivement la méthode.

D. Prendre deux plaquettes simultanément.

Réponse : B

Explication : Après les 28 comprimés, commencer la plaquette suivante dès le lendemain. Les jours sans hormone sont déjà prévus dans le conditionnement lorsqu’il comporte des placebos.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions pour les clientes sous COC », p. PDF 55.

Question 38. Une cliente sous pilule combinée a oublié un seul comprimé actif depuis moins de 48 heures, sans autre oubli. Quelle est la conduite à tenir ?

A. Prendre le comprimé dès qu'elle s'en souvient, même si deux comprimés sont pris le même jour, puis continuer.

B. Arrêter la plaquette jusqu'aux prochaines règles.

C. Prendre uniquement une contraception d'urgence.

D. Attendre sept jours avant de reprendre la pilule.

Réponse : A

Explication : Prendre le comprimé dès que possible et poursuivre à l’heure habituelle, même si cela conduit à deux prises le même jour. Dans cette situation isolée de moins de 48 heures, une protection supplémentaire n’est généralement pas nécessaire.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Oubli d’un comprimé actif », p. PDF 55. CDC, U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2024, Combined Hormonal Contraceptives, conduite après oubli de pilule.

Question 39. Une utilisatrice d’un patch combiné à la norelgestromine et à l’éthinylestradiol constate un décollement depuis moins de 24 heures. Quelle conduite est appropriée ?

A. Remettre ou remplacer rapidement le patch ; aucune protection supplémentaire n'est généralement nécessaire selon le support.

B. Arrêter toute contraception pendant un mois.

C. Prendre obligatoirement une contraception d'urgence.

D. Doubler la dose du patch.

Réponse : A

Explication : Replacer le patch s’il adhère correctement ou le remplacer sans délai. Pour un décollement connu de moins de 24 heures, une méthode d’appoint n’est généralement pas nécessaire ; suivre la notice du produit.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions pour le patch combiné », p. PDF 56.

Question 40. Une utilisatrice d’un anneau vaginal combiné à l’étonogestrel et à l’éthinylestradiol, de type NuvaRing, le laisse hors du vagin plus de trois heures pendant la deuxième semaine. Quelle conduite est indiquée ?

A. Le remettre dès que possible et utiliser une méthode d'appoint pendant sept jours.

B. Le jeter et attendre les prochaines règles.

C. Le laisser hors du vagin jusqu'à la fin du cycle.

D. Insérer deux anneaux pendant sept jours.

Réponse : A

Explication : Pour cet anneau, une sortie de plus de trois heures pendant la première ou la deuxième semaine impose une remise en place rapide et une protection complémentaire pendant sept jours.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Instructions pour l’anneau combiné », p. PDF 57.

Question 41. Une femme de 38 ans présente une migraine avec aura. Quelle catégorie OMS est indiquée pour les contraceptifs hormonaux combinés ?

A. Catégorie 1.

B. Catégorie 2.

C. Catégorie 3.

D. Catégorie 4.

Réponse : D — Catégorie 4

Explication : La migraine avec aura contre-indique les contraceptifs hormonaux combinés en raison du risque vasculaire, notamment d'accident vasculaire cérébral.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Critères médicaux d'éligibilité des CHC », p. PDF 60.

Question 42. Une cliente présente une thrombose veineuse profonde aiguë, avant mise sous anticoagulation, et demande un contraceptif hormonal combiné. Quelle décision est appropriée ?

A. Le proposer comme premier choix.

B. Le proposer uniquement les jours de règles.

C. Le considérer comme catégorie 4 et rechercher une autre option.

D. Doubler la dose pour compenser le risque.

Réponse : C

Explication : Une TVP aiguë avant traitement anticoagulant correspond à une contre-indication aux contraceptifs combinés. Il faut choisir une autre option adaptée à la situation clinique.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Thrombose veineuse et critères d'éligibilité des CHC », p. PDF 60.

Question 43. Lors d'une réception de produits contraceptifs, quelle vérification doit être prioritaire ?

A. Vérifier uniquement la couleur des cartons.

B. Comparer l'identité et les quantités avec le bon de livraison, contrôler les lots, les dates de péremption et l'intégrité.

C. Ranger immédiatement les produits sans les compter.

D. Distribuer les produits dont l'emballage est endommagé pour éviter la perte.

Réponse : B

Explication : La réception doit vérifier la concordance avec les documents, les quantités et la qualité : lots, dates de péremption et intégrité. Les produits non conformes doivent être isolés et signalés.

Source : Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire, Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, p. PDF 129–131, Réception des produits.

Étude de cas 4

Aïcha, 16 ans, élève en classe de troisième, vit avec sa mère dans un quartier périphérique. Depuis plusieurs mois, elle entretient une relation avec un jeune homme de 22 ans. Par manque d'informations sur la santé sexuelle et reproductive et faute de communication avec ses parents, elle n'utilise aucune méthode contraceptive. Elle découvre qu'elle est enceinte. Craignant la réaction de sa famille et l'arrêt de ses études, elle envisage un avortement clandestin. Les questions 44 à 46 se rapportent à cette situation.

Question 44. Parmi les facteurs ci-dessous, lequel constitue une cause de grossesse précoce chez Aïcha ?

A. L'accès facile aux services de santé adaptés aux jeunes.

B. La méconnaissance des méthodes contraceptives.

C. Le suivi régulier par un professionnel de santé.

D. L'existence d'une bonne communication familiale.

Réponse : B

Explication : Le cas décrit un manque d'information et l'absence d'utilisation contraceptive. La confidentialité, une information adaptée et l'accès aux services sont essentiels pour prévenir les grossesses non désirées.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Contraception des adolescents », p. PDF 127–128.

Question 45. Quelle conséquence de la grossesse précoce peut affecter directement la scolarité d'Aïcha ?

A. Augmentation des performances scolaires.

B. Développement d'une autonomie financière.

C. Arrêt ou perturbation de la scolarité.

D. Amélioration de l'intégration sociale.

Réponse : C

Explication : Une grossesse précoce peut perturber la fréquentation scolaire ou entraîner un abandon. Le soutien familial, scolaire et sanitaire doit viser le maintien ou la reprise des études.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Adolescents, counseling et prévention des grossesses non désirées », p. PDF 127–128. OMS, Adolescent pregnancy, conséquences sociales.

Question 46. Quelle stratégie aurait pu contribuer à prévenir cette situation ?

A. Limiter l'accès des jeunes à l'information.

B. Décourager les discussions entre parents et enfants.

C. Renforcer l'éducation à la santé sexuelle et reproductive.

D. Retirer les adolescentes de l'école.

Réponse : C

Explication : Une éducation adaptée à l'âge, associée à des services accessibles et confidentiels, permet des choix éclairés. Exclure les adolescentes de l'école ou de l'information aggrave leur vulnérabilité.

Source : INFAS, SR PF L2.pdf, « Contraception des adolescents, accès aux services », p. PDF 127–128.

Question 47. Parmi les propositions suivantes, quels sont les principes fondamentaux de la participation communautaire en gestion de l'hygiène menstruelle (GHM) ?

A. Inclusion.

B. Équité.

C. Transparence.

D. Durabilité.

E. Compétition.

Réponse : A, B, C et D

Explication : La participation doit inclure les personnes concernées, réduire les inégalités, rendre les décisions compréhensibles et assurer la continuité des actions. La compétition n'est pas un principe

fondamental de cette démarche.

Source : UNICEF, Guidance on Menstrual Health and Hygiene, 2019, section 2.1 ; Community Engagement, guide SBC, principes de participation, inclusion et redevabilité.

Question 48. Associez chaque acteur de la gestion de l'hygiène menstruelle à sa responsabilité principale. Choisissez la bonne combinaison.

Acteur	Responsabilité
1. Agents de santé	a. Conseiller, former et prendre en charge les complications liées à la santé menstruelle.
2. Écoles et enseignants	b. Intégrer la GHM dans les activités éducatives et garantir un environnement scolaire sécurisé.
3. Familles	c. Apporter un soutien moral, matériel et financier.
4. Leaders communautaires	d. Sensibiliser et favoriser l'acceptation sociale de la menstruation.

A. 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d.

B. 1-b ; 2-a ; 3-d ; 4-c.

C. 1-c ; 2-d ; 3-a ; 4-b.

D. 1-d ; 2-d ; 3-b ; 4-a.

Réponse : A — 1-a ; 2-b ; 3-c ; 4-d

Explication : Les soignants accompagnent la santé menstruelle ; l'école organise l'éducation et un environnement adapté ; les familles apportent leur soutien ; les leaders contribuent à la sensibilisation et à l'acceptation sociale.

Source : UNICEF, Guidance on Menstrual Health and Hygiene, 2019, p. PDF 34, 44 et 50–51, interventions dans les secteurs santé, éducation et communauté.

Question 49. Après un viol, la prophylaxie post-exposition (PPE) contre le VIH doit être initiée :

A. Dans les 72 heures.

B. Après un mois.

C. Après six mois.

D. À tout moment.

Réponse : A — Au plus tard dans les 72 heures

Explication : La PPE doit commencer le plus tôt possible, idéalement dans les 24 heures et au plus tard dans les 72 heures, après évaluation. Il ne faut pas attendre la fin de cette fenêtre.

Source : OMS, Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis, 2024, initiation de la PPE.

Question 50. Parmi les sources des représentations liées au genre, on trouve :

A. La famille.

B. L'école.

C. Les médias.

D. Toutes les réponses ci-dessus.

Réponse : D — Toutes les réponses ci-dessus

Explication : Les représentations de genre s'acquièrent et se transmettent notamment dans la famille, à l'école et par les médias. Elles sont sociales et peuvent évoluer.

Source : OMS, Gender and health, Questions and answers, 24 mai 2021, normes sociales, éducation et médias.

Références documentaires

INFAS — SR PF L2.pdf, Santé de la reproduction et planification familiale, licence 2 sage-femme, année 2021–2022. Document de cours consulté en priorité.

Ministère de la Santé de Côte d'Ivoire — Manuel de procédures du SIGL intégré des produits de santé, 2018, calcul CMM et MSD, inventaire, réception.
https://dap.ci/wp-content/uploads/2021/04/Manuel-de-procedures-SIGL-integre-CI_final-VFF-1.pdf

USAID DELIVER — The Logistics Handbook, 2011, chapitre 4, système Max-Min en revue continue.
https://ghsupplychain.org/sites/default/files/2019-07/Logistics%20Handbook.pdf

CDC — U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2024, Combined Hormonal Contraceptives.
https://www.cdc.gov/contraception/hcp/usspr/combined-hormonal-contraceptives.html

NICE — Contraception emergency, Management, contraception après accouchement et critères MAMA.
https://cks.nice.org.uk/topics/contraception-emergency/management/management/

UNICEF — Guidance on Menstrual Health and Hygiene, 2019.
https://www.unicef.org/documents/guidance-menstrual-health-and-hygiene

UNICEF — Community Engagement, guide Social and Behaviour Change, participation, inclusion et redevabilité.
https://www.unicef.org/cameroon/media/1321/file/Understand%20-%20Community%20Engagement.pdf.pdf

OMS — Guidelines for HIV post-exposure prophylaxis, 2024.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240095137

OMS — Adolescent pregnancy, conséquences sanitaires et sociales.
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

OMS — Gender and health, Questions and answers, 24 mai 2021.
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/gender-and-health